



MÓDULO: INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS

PROFESSOR: Mariana Bispo

EVOLUÇÃO DA INFECÇÃO: EDEMA, CELULITE E ABSCESSO

Características	Edema (inoculação)	Celulite	Abscesso
Duração	0-3 dias	1-5 dias	4-10 dias
Dor	Leve a moderada	Grande e generalizada	Moderada a grave e localizada
Tamanho	Pequeno	Grande	Pequeno
Localização	Difusa	Difusa	Circunscrita
Palpação	Mole, gelatinosa	Dura	Centro amolecido, flutuante
Cor	Normal	Vermelho	Centro brilhante, periferia vermelha
Progressão	Crescente	Crescente	Decrescente
Temperatura	Ligeiramente aquecida	Quente	Moderadamente aquecida
Perda da função	Mínima ou nenhuma	Grave	Moderada a grave
Fluido tecidual	Edema	Vestígios de pus, serossanguinolento	Pus
Mal-estar	Leve	Intenso	Moderado a intenso
Gravidade	Baixa	Alta	Moderada a alta
Bactérias	Aeróbica	Mista	Anaeróbica

ESPAÇOS FASCIAS

- Infecção tem duas origens principais:
 - (+) Periapical: necrose pulpar que evolui para invasão do tecido periapical
 - Periodontal: bolsa periodontal profunda que permite a inoculação das bactérias nos tecidos subjacentes
- No osso esponjoso, a infecção se dissemina em todas as direções até o osso cortical fino → perfura e vai para o tecido mole (preferencialmente pelas linhas de menor resistência)



- Associação aos dentes

Qualquer dente	Dentes superiores	Dentes inferiores	Pescoço
Vestibular Bucal Subcutâneo	Infraorbitário Bucal Infratemporal Seios maxilares e outros seios paranasais Trombose do seio cavernoso	Espaço do corpo da mandíbula Espaços perimandibulares Submandibular Sublingual Submentoniano Espaço mastigador Submassetérico Pterigomandibular Temporal superficial Temporal profundo	Faríngeo lateral Retrofaríngeo Pré-traqueal Espaço potencial Pré-vertebral

ANGINA DE LUDWIG

- Quando os espaços perimandibulares (submandibular, sublingual e submentoniano) são bilateralmente envolvidos
- Celulite de evolução rápida que pode obstruir as vias aéreas
- Dissemina, posteriormente, para os espaços fasciais profundos do pescoço

FASCIITE NECROSANTE

- Celulite de progressão rápida pelo tecido subcutâneo que segue o músculo platísmo para baixo, no pescoço e para a parede anterior do tórax
- Necrose ou gangrena dos tecidos moles
- (+) homens
- Quase sempre odontogênica
- Alta mortalidade (40%) e sequelas estéticas
- Fatores predisponentes: diabetes e alcoolismo

TROMBOSE SÉPTICA DO SEIO CAVERNOSO

- Primeiros sinais de trombose do seio cavernoso: edema orbitário e paralisia no NC VI (abducente)
- A presença da bactéria estimula as vias de coagulação, resultando em uma trombose séptica (tromboflebite) do seio cavernoso → raro, porém com alto risco de morte
- Rota anterior
 - Quando as infecções do espaço infraorbitário invade a veia infraorbitária e do seio maxilar invade a veia oftálmica inferior e elas desaguam na veia oftálmica comum e estender-se ao seio cavernoso
- Rota posterior
 - Através do espaço infratemporal pelas veias emissárias do plexo pterigoide

Tratamento medicamentoso comum as outras infecções + manitol (diurético ↓ edema) + heparina (anticoagulante)

PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO

1: determinar a gravidade da infecção

- História Completa, queixa, tempo de duração, rapidez do progresso, sinais flogísticos, trismo, dificuldade de mastigação, disfagia, dispneia, mal-estar, febre, presença de tumefação e eritema
- Dificuldade de entubação: classificação de Mallampati

Classe 1	Tonsilas, úvula e palato mole totalmente visíveis	
Classe 2	Palato duro e mole, parte superior das tonsilas e úvula visíveis	
Classe 3	Palato mole e duro e base da úvula visíveis	
Classe 4	Apenas o palato duro visível	

- Exames laboratoriais: hemograma (leucograma), proteína C reativa (até 5)

2: avaliar o estado dos mecanismos de defesa do hospedeiro

- Condições médicas que comprometem a defesa do hospedeiro
- Fármacos que comprometem a defesa do hospedeiro

3: decidir os cuidados (CD ou CTBMF)

- Tratamento ambulatorial X tratamento hospitalar

4: tratamento cirúrgico da infecção

- Necessidade de remover a causa (tratamento primário) → endodontia, extração e tratamento periodontal
- Extraírem um dente durante a drenagem de abscesso NÃO dissemina a infecção, só tem que fazer antibiótico profilático
 - O fator local que impede a exodontia no momento é a pericoronarite moderada ou grave → contra indicação absoluta
- Proporcionar a drenagem do pus acumulado e dos restos necróticos, reduzindo-os ↓tensão dos tecidos ↓pressão hidrostática na região ↑suprimento sanguíneo ↑chegada das defesas

5: suporte médico para o paciente



6: escolher e prescrever os antibióticos apropriados

- Determinar a necessidade de administrar antibióticos

Indicações para o uso de Antibióticos

- Tumorção estendida além dos processos alveolares → indica que indicando a defesa do hospedeiro é inadequada para conter a infecção
- Celulite
- Trismo
- Linfadenopatia
- Temperatura alta 38°C
- Pericoronarite grave
- Osteomielite

Situações nas quais o uso de antibióticos não é necessário

- Exigência do paciente
- Dor de dente de rotina
- Abscesso periapical → exodontia com sistema imune ok resolve
- Alvéolo seco → autolimitado e causado por uma fibrinólise prematura (perda do coágulo de sangue).
- Extrações de múltiplos dentes em pacientes não comprometidos
- Pericoronarites moderadas (inflamação somente no opérculo) → irrigação com peróxido de hidrogênio ou clorexidina + exodontia
- Abscesso alveolar drenado

7: administrar o antibiótico apropriadamente

8: avaliar frequentemente o paciente

OSTEOMIELE

- (+) Mandíbula → se torna facilmente isquêmico por receber seu suprimento sanguíneo primário apenas pela artéria alveolar inferior + densa lâmina cortical (impede a penetração dos vasos sanguíneos periosteais)
- Raramente envolve a maxila → suprimento sanguíneo muito mais rico e deriva de diversas artérias (forma uma complexa rede de vasos de suprimento)
- Raramente ocorre se as defesas do hospedeiro estiverem intactas
- Condições que suprimem as defesas:
 - Diabetes
 - Alcoolismo
 - AIDS
 - Abuso de drogas intravenosas
 - Má nutrição
 - Doenças mioproliferativas (leucemia)
 - Doença de células falciformes
 - Quimioterapia
 - Medicamentos relacionadas:
 - Esteroides
 - Agente quimioterápicos
 - Bifosfonatos
- Condições locais → alteram o suprimento sanguíneo
 - Radioterapia
 - Osteopetrose



- Doenças ósseas

Apresentação clínica e radiográfica

Osteomielite supurativa aguda

- Foco contínuo
- Progressiva
- Hematogênica
- Muita dor, febre, inchaço e eritema
- Leucocitose com desvio à esquerda
- Elevada taxa de sedimentação de eritrócitos e de proteína C reativa
- Pouca ou nenhuma alteração radiográfica → são necessários 10-12 dias para que a perda óssea seja detectável

Osteomielite crônica

- Multifocal recorrente
- Osteomielite de Garré → aparência radiográfica de casca de cebola
 - Em pacientes jovens
 - Reação do periósteo que estimula a depositar camadas de osso
- Supurativa (presença de fístula) ou não supurativa
- Aumento da radiolucência → padrão uniforme ou salpicado (aspecto de “roído por traça”)
- Pode haver algumas áreas de radiopacidade dentro das áreas radiolúcidas → ilhas de osso que não são reabsorvidas (sequestros)
- De longa duração, pode haver uma área de maior radiodensidade circundando a área radiolúcida (invólucro) → reação do tipo osteíte (↑produção do osso como resultado da reação inflamatória)

Tratamento

- Atb (clindamicina ou penicilinas + metronidazol) + manejo dos eventos e condições que precipitam □ fazer coloração de gram e teste de sensibilidade
- Sequestrectomia
 - Remoção de fragmento de osso infectados e avasculares (necrótico) até que seja encontrado sangramento ósseo ativo
 - Enviar os espécimes de osso para cultura aeróbica e anaeróbica e teste de sensibilidade e exame histopatológico
- Saucerização / corticotomia / descorticação
 - Remoção ou perfuração da cortical óssea (quase sempre avascular e infectada)
 - Posicionamento do periósteo vascularizado adjacente à medula óssea pra tornar possível um aumento do fluxo sanguíneo e cicatrização
- Biópsia para confirmar que é osteomielite